Estudio exploratorio de indicadores poblacionales y sanitarias de la República Argentina

Grupo: *Las Nulls*

Estudiantes :
1189/24 - Tamara Diana Argañaraz
151/15 - Yamila Daniela Burrafato
572/23 - Carolina Belén Fonseca

Universidad de Buenos Aires (UBA)
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)
Laboratorio de Datos
Curso de Verano
19 de febrero de 2026

1. Resumen

El acceso a la salud en la Argentina es una de las problemáticas que es encuentran en discución en estos últimos tiempos. En este presente trabajo se tiene como objetivo general identificar, analizar y estblecer, si existe o no, una relación entre las enfermedades terminales, las variables demográficas y el acceso a los servicios de salud en la población Argentina. Para ello, nos enfocaremos en el período comprendido entre los dos últimos censos realizados en nuestro país, en los años 2010 y 2022. Planteamos la problemática diferentes puntos de vistas, así poder determinar si factores sociales, como la edad, el sexo, la distribución geográfica, pueden ser indicadores si existe alguna relación entre la cobertura y la defunciones. Al tener datos de diferentes fuentes, se priorizó la estructuración una base de datos que nos facilite su manipulación y vinculacion. Para su construcción y estructuramiento nos baseamos en un Diagrama Entidad-Relación (DER). Debido a la gran fragmentación del sistema de salud argentino, su gran extensión geografía y desigualdades estructurales, no nos fue posible encontrar una relación directa entre la cobertura de salud y las muertes de la población argentina. Con los datos analizados, depende mucho factores de índole sociales, económicos y teritoriales.

2. Introducción

El estado de salud poblacional depende de un conjunto de determinantes sociales que incluyen factores socioeconómicos, educativos, demográficos y de género, así como la disponibilidad de infraestructura sanitaria. El impacto de estos factores conlleva variaciones significativas

en las tasas de mortalidad de dicha población [1]. En este trabajo estamos interesados en analizar si en Argentina existe alguna correlación entre las enfermedades que llevan a la muerte y variables demográficas o de acceso a la salud.

El sistema de salud de Argentina está compuesto por tres sectores poco integrados entre sí y fragmentados: el público (a cargo del Estado); el de las obras sociales (vinculados a la inserción laboral formal) y el privado (empresas de medicina prepaga orientadas a los sectores de mayor poder adquisitivo) [2]. Para este análisis, utilizaremos los datos de los dos últimos censos realizados en Argentina (2010 y 2022) [3], junto con registros de establecimientos de salud [4] y defunciones por provincia [5].

Como se mencionó anteriormente, el objetivo central es identificar posibles relaciones entre la cobertura de salud y los perfiles de mortalidad. Al tener datos distintas fuentes de información, es necesario construir una base de datos que permita consultas cruzadas. Para la construcción de nuestra base de datos, nos basamos en un modelo de Entidad-Relación (ER) que estructura esta información multidimensional (ver Subsección 3.2).

3. Procesamiento y Calidad de Datos

En esta sección nos encargamos de analizar las tablas de Establecimientos de Salud y Defunciones a través de procedimientos y conceptos visto en clases: Evaluaremos la normalización de las tablas y trataremos de organizar los datos necesarios para reducir la redundancia y mejorar la integridad de la base de datos. A la vez, utilizaremos la técnica GQM (Goal-Question-Metric) u Objetivo-Pregunta-Métrica para determinar la calidad de los datos y mejorarla.

Estudiaremos solamente los datos necesarios de todas las tablas dadas para armar un Diagrama Entidad-Relación (DER). Representaremos una estructura de una base de datos, definiendo sus entidades, los atributos que la componen y las relaciones que hay entre ellas. Con eso, planificaremos nuestro Modelo Relacional (MR), que nos permitirá vincular los datos entre las distintas tablas, que estarán normalizadas tratando de cumplir las primeras tres formas normales, a través de claves principales (PK) y claves foraneas (FK). Permitiéndonos poder moldear nuestras propias tablas.

3.1. Armado del Diagrama Entidad-Relación (DER)

La base de nuestro DER empezó intentando generalizar la idea de las tablas que se nos presentaron y, a través de lo que nos pedían para resolver los problemas, ver que datos nos interesaban y que datos podíamos descartar. Buscamos cuáles datos podrían ser nuestras claves principales de las tablas que nosotras moderaremos, ver las relaciones que había entre los atributos y además de observar cuáles elementos tienen en común.

Con eso creamos 7 entidades, con sus respectivos atributos más importantes y sus claves principales, y donde existen 6 relaciones:

A continuación se explicará brevemente cómo se realizaron las tablas y de dónde se sacaron los datos:

- Provincias: Obtuvimos los Ids y Nombres de las Provincias de la tabla “defunciones”, y consideramos Id-Provincia como nuestra clave primaria.
- Departamentos: De la tabla de “instituciones de salud” seleccionamos los Nombres de los Departamentos de cada Provincia y creamos una nueva clave principal que representen los Ids (explicado en desiciones tomadas).
- Establecimientos de Salud: Extraemos los Ids y Nombres de los Establecimientos de Salud de la tabla de “instituciones de salud”, siendo nuestra clave principal el Id-Establecimiento.
- Tipologías: Obtuvimos sus Nombres e Id de la tabla de “instituciones de salud”. Pero también le creamos una nueva clave principal que representen sus Ids (explicado en desiciones tomadas).
- Origen Financiero: Los obtuvimos de la tabla de “instituciones de salud” y, como solo venían los nombres de los orígenes financieros, creamos nuestra clave primaria dandoles un código para cada una.
- Censos: Al arreglar las tablas de “censo 2010” y “censo 2022”, obtuvimos el Año, Cobertura de Salud, Sexo y Grupo de Edad. Consideramos los cuatros atributos como claves principales debido a que estos elementos combinados no se repetían en ninguna fila a la vez.
- Defunciones: Extraemos Año, Nombre de Causa de Muerte, Sexo y Grupo de Edad de la tabla de “defunciones”, siendo todas nuestras claves principales. Sabemos que lo más ideal hubiera sido hacer una entidad débil que tuviera los nombres y subcategorías, y que una de las claves sea el Id de las Causas de Muerte, pero debido a que esto puede complejizar innecesariamente la solución del DER, por consejo de los profesores, descartamos la idea. Consideramos los cuatros atributos como claves principales debido a que estos elementos combinados no se repetían en ninguna fila a la vez.
- Se realizan: Tiene los datos de la Cantidad de habitantes por Provincia, Cobertura de Salud, Año, Sexo y Grupo de Edad, extraído de las tablas de los “censo 2010 y 2022”.
- Se producen: Tiene los datos de la Cantidad de Casos de muertes por Provincia, Causa de Muerte, Año, Sexo y Grupo de Edad, extraído de las tablas de “defunciones”.

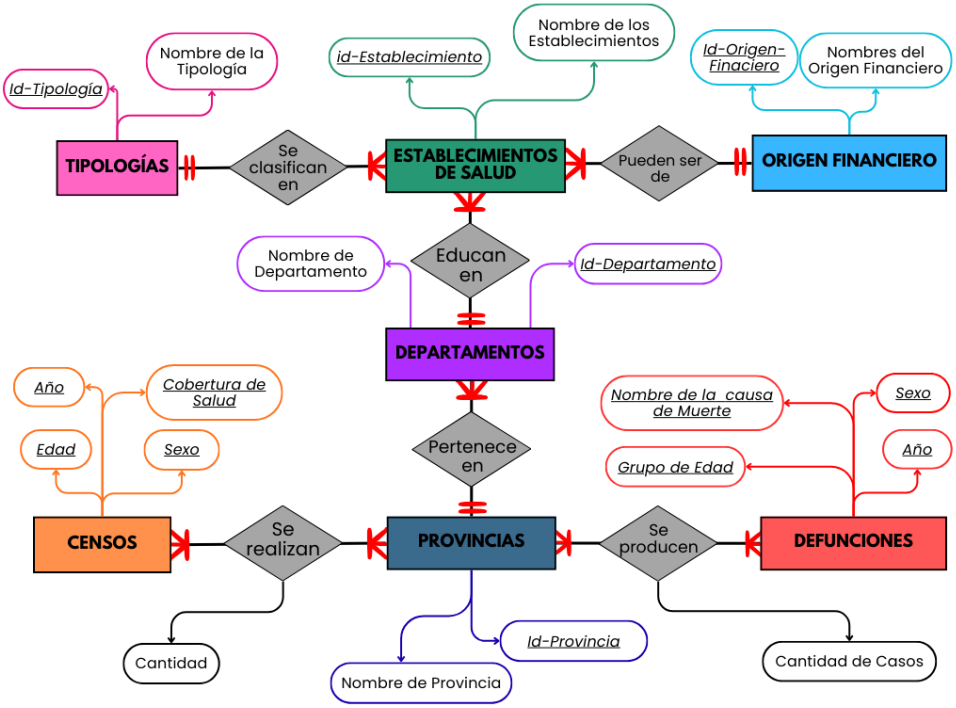


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación (DER)

3.2. Armado del Modelo Relacional (MR)

Para el armado del MR, nos basamos en las entidades, atributos y relaciones del DER. Lo armamos en parte: primero las entendidas con sus atributos, sus claves principales y las claves foráneas (Foregin Keys) y luego, si era necesario, las de las relaciones. Después verificamos que estuvieran Normalizadas y señalamos de dónde provenian las Foregin Keys.

Por ende, el MR quedó así:

- La entidad de Provincia quedó igual que en el DER, siendo Id-Provincia su PK.
- La entidad de Departamento, como tiene una relación de uno-a-muchos con Provincia, además le tuvimos que agregar Id-Provincia que será nuestra Foregin Keys (FK).
- La entidad de Tipologías quedo igual que en el DER, siendo Id-Tipología su PK.
- La entidad de Origen Financiero quedo igual que en el DER, siendo Id-Origen-Financiero su PK.
- La entidad de Establecimientos de Salud también tiene una relación de uno-a-muchos con Departamento, Tipologías y Origen Financiero, por lo que le tuvimos que agregar Id-Departamento, Id-Tipología e Id-Origen-Financiero (FK).
- La entidad de Censos quedo igual que en el DER, siendo Año, Cobertura de Salud, Sexo y Grupo de Edad sus PK.
- La entidad de Actividades quedó igual que en el DER, siendo Año, Nombre de Causa de Muerte, Sexo y Grupo de Edad sus PK.

- La relación Se Realizan tiene como sus PK Id-Provincia, Año, Cobertura de Salud, Sexo y Grupo de Edad debido a que Provincia y Censos tienen una relación de muchos-a-muchos
- La relación Se Producen tiene como sus PK Id-Provincia, Año, Nombre de Causa de Muerte, Sexo y Grupo de Edad debido a que Provincia y Defunciones tienen una relación de muchos-a-muchos

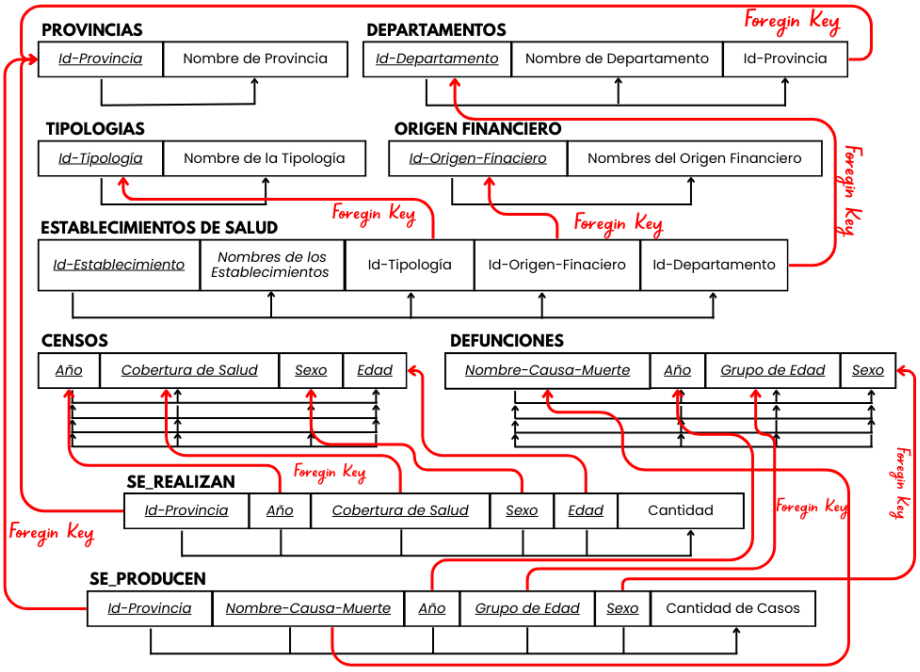


Figura 2: Modelo Relacional (MR)

3.3. Forma Normal de Establecimientos de Salud

La tabla de Establecimientos de Salud la formamos seleccionando, modificando y uniendo los datos de la tabla original, “Instituciones de salud”, y algunas de nuestras tablas hechas, “Departamentos”, “Tipologías” y “Origen Financiamiento”. Formándola con los siguientes atributos: “Id Establecimiento”, “Nombre del Establecimiento”, “Id Tipología”, “Id Origen Financiamiento” e “Id Departamento”.

En esa nueva tabla, nuestra claves principal (PK) van a hacer los Ids de los establecimientos de salud, ya que es la única que cumple la definición de no tener datos (1-tupla) repetidos. La tabla se encuentra en Primera Forma Normal (1FN) porque los elementos de las celdas de cada columna son atómicos, consideramos los nombres de los establecimientos como String’s “grandes”. A su vez, se encuentran en Segunda Forma Normal (2FN) porque todas los atributos dependen de la clave principal, por ejemplo, si queremos saber en qué departamento se ubica cierto establecimientos con tal nombre, tipología y origen financiero, con solo buscar el Id, encontramos toda la información. Y también está en Tercera Forma Normal (3FN) porque cumple la 2FN y no hay dependencia funcional transitiva.

3.4. Forma Normal de Defunciones

La tabla de Defunciones la formamos seleccionando y modificando los datos de la tabla original, “Defunciones”, quedándonos con los siguientes atributos: “Nombre de Causa de Muerte”, “Año”, “Grupo de Edad” y “Sexo”.

En esta nueva tabla consideremos todos los atributos como nuestras PKs, debido que los datos solos por separado provocarían tuplas repetidas, en cambio juntan forman una tuplas de datos que no se repetían en ninguna fila. Esto nos permite poder asumir que la tabla se encuentra en 2FN y 3FN porque todas los atributos dependen de todos y no hay dependencia funcional transitiva. A la vez, está en 1FN porque los elementos de las celdas de cada columna son atómicos (los nombres de las causas de muerte no se pueden dividir)

3.5. Análisis GQM en Establecimientos de Salud

Se observó un problema de instancia en el atributo de calidad ‘Id Provincia’ de la tabla Establecimientos de Salud, afectando al 20,83 % de los registros, debido a que algunas provincias estaban asociadas a más de un ID, cuando cada provincia debía tener un único identificador.

Para calcular la métrica, dividimos la cantidad de provincias que poseen más de un ID por el total de provincias (23 provincias + CABA), respondiendo a la pregunta: ¿Cuál es la proporción de provincias que tienen más de un ID?

Como correción, asignamos el ID correspondiente a cada provincia.

3.6. Análisis GQM en Defunciones

Se observó principalmente un problema de completitud en el atributo de calidad ’Sexo’ de la tabla Defunciones por falta de información, con una proporción de 0.20 % . Además, podríamos inducir también un problema de exactitud, pues si el sexo no se conoce, la exactitud del dato también se ve afectada.

Los datos no afectaban en gran magnitud a los registros. Luego, como correción, asignamos el nombre ‘Sin definir’ a los valores descriptos como ‘desconocido’ o ‘indeterminado’ y mantuvimos intactos a los valores ‘femenino’ y ‘masculino’.

Para calcular la métrica,tomamos la cantidad de fallecidos con el sexo ‘indeterminado’ y/o ‘desconocido’ y lo dividimos por el total de fallecidos, respondiendo a la pregunta: ¿Cuál es la proporción de datos donde el sexo no está definido?

4. Decisiones Tomadas

Cuando estábamos moldeando las tablas a través del DER y MR, tuvimos que tomar muchas decisiones:

Cuando hacíamos las tablas de Provincias, nos dimos cuenta de que había dos categorías más: Ïndeterminado"(98) que son los casos dónde la información es insuficiente, y "Sin declarar-Desconocido-Ignorado" (99) que son los casos en los que no hay respuesta o es inapropiada. Para eso, decidimos no considerar esps casos porque eran muy pocos y para análsisi de los datos y cración de los gráficos no los consideramos.

A su vez, las tablas de Defunciones y 'se producen' tienen los atributos Grupo Etario y Sexo. En ambas decidimos no considerar los casos donde el rango de edad esta sin indentificar y el sexo como indeterminado. Debido a que la cantidad de casos que correspondian a esos atributos eran insignificativas en comparación al total de casos que estudiamos.

En el caso de los Ids de las tablas de Departamentos y Tipologías sufrían de un problema de inconsistencia. Es decir, que los Id que tenían que representar un solo departamento o tipología, tenían varias. En Departamentos, se debía por asociarlos solo a las provincias donde pertenecían o error al subir los datos. Y en Tipologías, porque los ids estaban relacionados a las siglas que representaban sus categorías; sentíamos que si uníamos los id con las siglas podríamos tener una problema innecesario a la hora de hacer las tablas y también porque al analizar la normalización de nuestras tablas, no iban a cumplir la 1FN. Por lo tanto, decidimos crearles nuevas Ids para cada Departamento por Provincia y para cada Tipologías.

Y, por último, las tablas de los Censos de 2010 y 2022. Compartían el tipo de información, sin embargo Censo 2010 poseía tres tipos de coberturas mientras que Censo 2022 cinco y eso se debía a que consideraba Obra social o prepaga (incluye PAMI) como tres coberturas diferentes. Por lo tanto, tomamos la decisión de que las coberturas de salud del censo de 2010, Obra social (incluye PAMI), Prepaga a través de obra social y Prepaga sólo por contratación voluntaria, sean una misma cobertura de salud llamada Obra social o prepaga (incluye PAMI) y su casos sean la suma de los casos de cada una.

5. Análisis de Datos

Para esta sección lo que hicimos fue, gracias a las tablas limpias, corregidas y moldeadas según tanto el DER como el Modelo Relacional, generar las tablas planteados en el enunciado del presente trabajo práctico. Con la idea, que a través de esas tablas, realizar gráficos que evalúen, midan y comparen ciertos datos para observar si hay alguna relación entre los establecimientos de salud, las cantidad de defunciones en un rango determinado de tiempo y la cantidad de personas con o sin cobertura médica entre los censos 2010 y 2022.

5.1. Tablas Realizadas

Provincia	Grupo Edad	Con Cob. 2010	Sin Cob. 2010	Con Cob. 2022	Sin Cob. 2022
Buenos Aires	De 0 a 14 años	2.230.507	1.643.068	2.183.542	1.645.128
Buenos Aires	De 15 a 34 años	2.850.048	2.145.986	2.832.382	2.418.209
Buenos Aires	De 35 a 54 años	2.423.430	1.255.181	3.068.766	1.533.103
Buenos Aires	De 55 a 74 años	1.889.938	452.068	2.349.377	490.794
Buenos Aires	De 75 años y mas	709.167	20.078	863.446	24.159

Cuadro 1: Consulta de Cobertura de Salud

Provincia	Origen	Cant.
Buenos Aires	Mixta	1
Buenos Aires	Municipal	66
Buenos Aires	Nacional	6
Buenos Aires	Privado	195
Buenos Aires	Provincial	54

Cuadro 2: Consulta de Establecimientos de salud por origen de financiamiento con terapia intensiva.

Edad	Sexo	Causa de Muerte
15 a 34 anios	femenino	Agresión con material explosivo
15 a 34 anios	femenino	Tumor maligno de la mama
15 a 34 anios	femenino	Tumor maligno del cuello del útero
15 a 34 anios	femenino	Absceso periamigdalino
15 a 34 anios	femenino	Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado

Cuadro 3: Consulta de causas de muerte por grupo etario y Sexo.

Nombre Causa de Muerte	Diferencia
Neumonía, organismo no especificado	18022
Infarto agudo del miocardio	5546
Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	4267
Otras Sepsis	3767
Taquicardia paroxística	3514

Cuadro 4: Consulta de cambios en las causas de defunción.

Provincia	Grupo Etario	Tasa de Mortalidad
Buenos Aires	0 a 14 años	14.062
Buenos Aires	15 a 34 años	28.2125
Buenos Aires	35 a 54 años	81.815
Buenos Aires	55 a 74 años	316.274
Buenos Aires	75 años y más	555.308

Cuadro 5: Consulta de Tasa de mortalidad por grupo etario en cada provincia.

5.2. Discusión de resultados

Existen diversas cuasas o enfermedad que pueden llevar a la muerte una persona. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene un sistema de codificación estandarizado para clasificar enfermedades, trastornos y problemas de salud, utilizado mundialmente para diagnósticos, estadísticas de mortalidad, morbilidad y gestión de recursos sanitarios, denomindo Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). En nuestra base de datos se utiliza la clasificación de la $10°$ revisión (ver en Apéndice, Tabla 6).

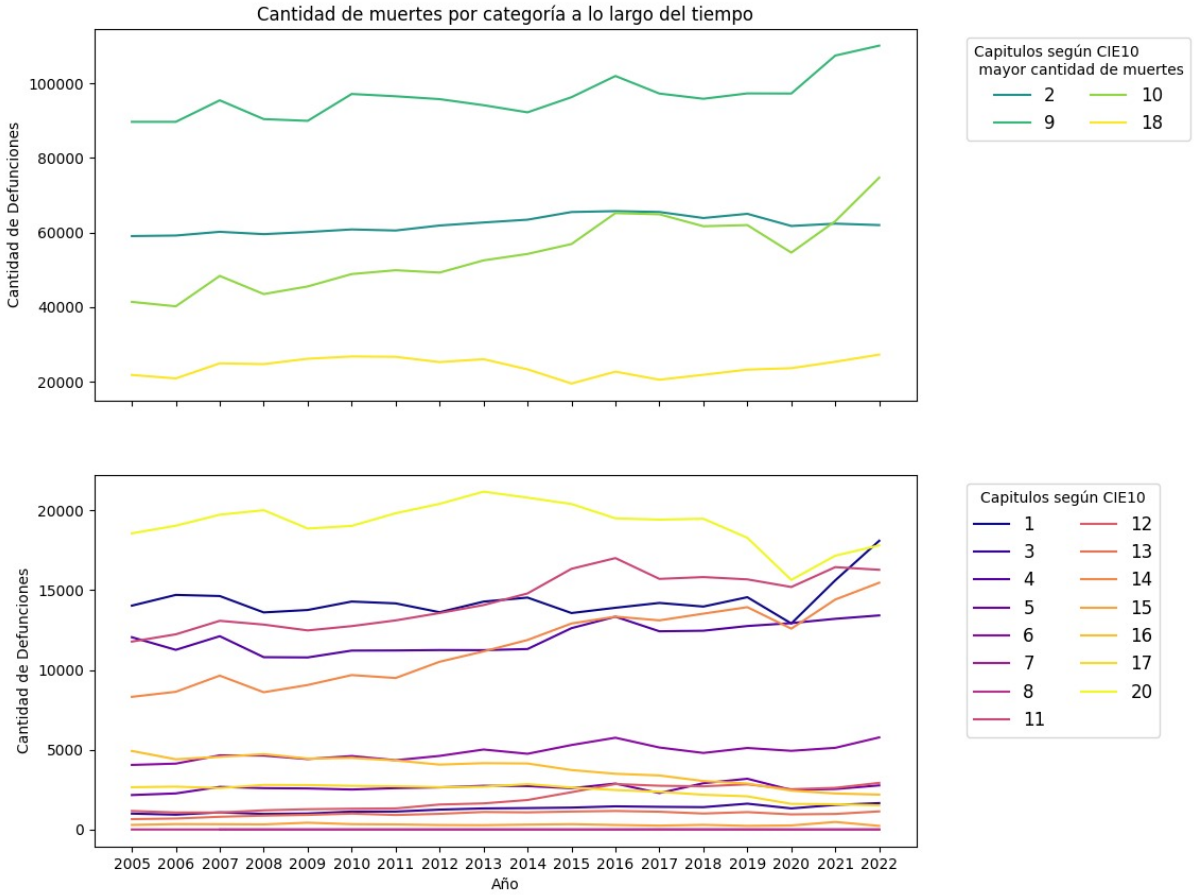


Figura 3: Cantidad de muertes entre los años 2005 y 2022. Cada color reprenta una causa de muerte dada por la clasificaión CIE10. El panel de arriba se muestra la evolución de las cusas que produjeron mayor cantidad de muertes en el periodo, mientras el paner de abajo están el resto de las casificaciones.

En la Figura 3 se muestra la variación de la cantidad de muertes según su causas dada por la clasificación CIE-10 entre los años 2005 y 2022. Se observa que las enfermedades del sistema circulatorio (Capítulo IX), las neoplasias (Capítulo II) y las enfermedades del sistema respiratorio (Capítulo X) son las principales causas de muerte en estos periodos.

No hay una variación apreciable entre las diferentes causas de muerte, excepto por las enfermedad respiratorías (Capítulo X), que se observa un incremento notable en las defunciones coincidiendo con la crisis sanitaria global y las enferemdades infecciosas y parasitarias (Capítulo I).

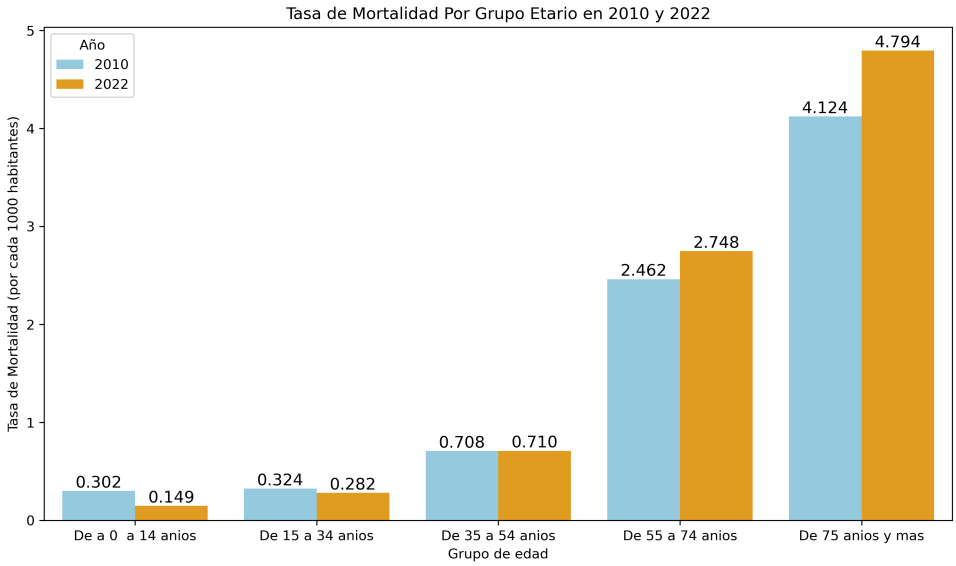
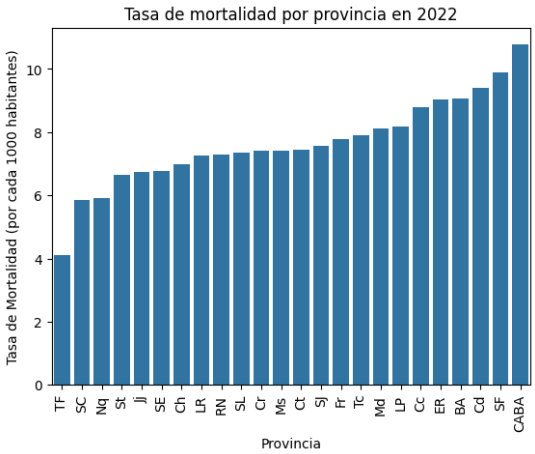
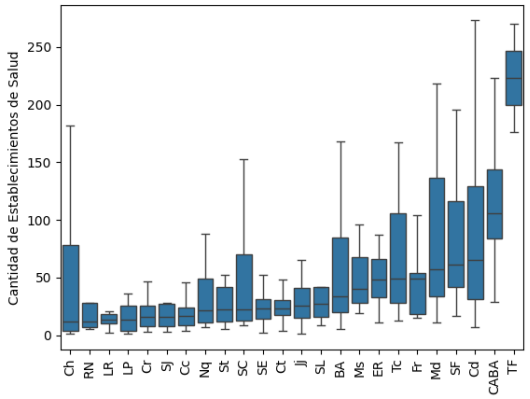


Figura 4: Comparación de las tasas de mortalidad cada 1000 habitantes para cada grupo etario entre los años 2010 y 2022

Si comparamos la tasa de mortalidad entre los años de los censos, es decir 2010 y 2022, como se muestra Figura 4, se puede ver diferencias significativas entre los diferentes grupos etarios. Para las infancias (habitantes entre 0 a 14 años), se obseva una disminución de la mortalidad. Sin embargo, para persona mayores a 75 años hay un considerable aumento, a diferencia de los otros grupos etario. Este incremento podría atribuirse tanto al proceso de transición demográfica y envejecimiento poblacional y las posibles secuelas de la reciente crisis sanitaria global en la población de mayor vulnerabilidad.



(a) Tasa de mortalidad para cada provincia.



(b) Cantidad de establecimientos de salud por departamentos de sin *outliers*.

Figura 5: Tasa de mortalidad y distribución de establecimiento de salud por departamento para cada provincia (incluyendo la juridicción de CABA) en el año 2022.

Sin embargo, si queremos ver si hay desigualdades estructurales en el sistema de salud, es necesario comparar la mortalidad con la infraestructura disponible. En la Figura 5a se observa que las tasas de mortalidad no son uniformes en el país, como era de esperar. Cabe resaltar que las provincias más pobladas son las que presentan las mayores tasas de mortalidad (Ver

Apéndice, Figura 8).

Por otro lado, al observar la Figura 5b se aprecian a simple vista las diferencias estructurales y de infraestructura condicionadas por la geografía y la densidad poblacional de cada jurisdicción, dejando en evidencia que el sistema de salud está altamente fragmentado. Si comparamos esto con los resultados de la Figura 5a, podemos inferir que la distribución desigual de los centros de salud puede contribuir sustancialmente a la tasa de mortalidad. Una aclaración importante es que la provincia de Tierra del Fuego solo se divide en dos departamentos, lo que explica la diferencia en la cantidad de centros de salud respecto a otras provincias.

En Córdoba, por ejemplo, hay muchos centros de salud distribuidos por departamento, pero es la tercera provincia con mayor tasa de mortalidad. Si observamos la Figura 6, vemos que muchos de sus habitantes no tienen cobertura de salud. Algo parecido sucede en Santa Fe; sin embargo, en esta provincia la desigualdad en la distribución de los establecimientos de salud es más marcada que en Córdoba. Por el contrario, Buenos Aires también presenta desigualdad entre sus departamentos, pero no es tan pronunciada como en los casos anteriores, siendo esta una de las provincias con más cantidad de distritos y una gran parte de su población sin acceso a cobertura médica. Por lo tanto, no resulta sencillo atribuir una relación directa entre estas variables, ni determinar cuál de las dos tiene mayor peso en las defunciones de una población determinada.

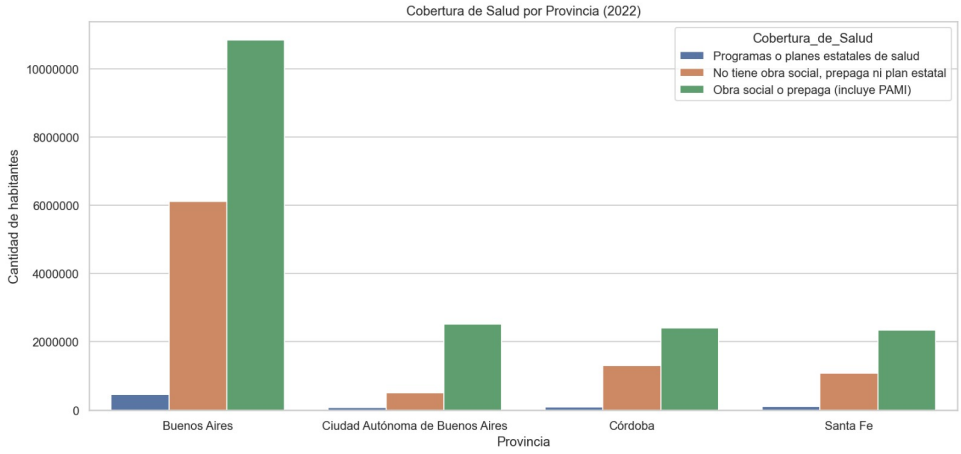


Figura 6: Comparación de las tasas de mortalidad cada 1000 habitantes para cada grupo etario entre los años 2010 y 2022

Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es el género (o sexo). Si vemos la tasa de mortalidad (Figura 7) siempre es mayor para la población masculina, excepto para CABA, y varia significativamente con la provincia.

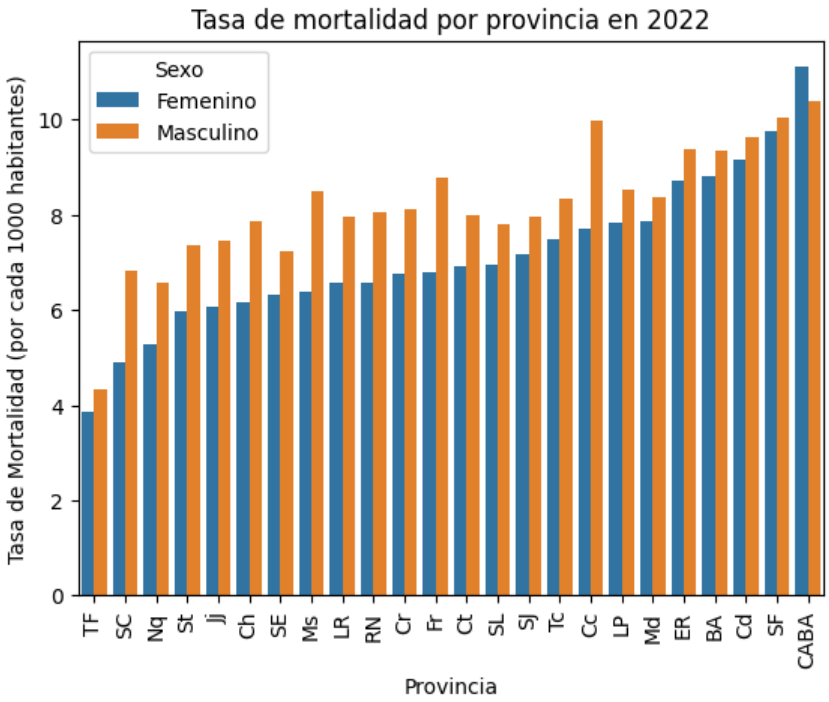


Figura 7: Comparación de las tasas de mortalidad cada 1000 habitantes para cada grupo etario entre los años 2010 y 2022

Por lo tanto, no podimos encontrar una relación directa entre la cusa de muerte y el acceso a la cobertura de salud. La Tasa de mortalidad depende de muchos factores, en espacial geograficos. Asimismo, la fragmentación del sistema de salud argentino introduce una variabilidad estructural que influye de manera diferenciada en el riesgo de mortalidad entre las diversas jurisdicciones del país.

6. Conclusión

El trabajo estuvo focalizado en el diseño de un modelo de datos relacional basado en un Diagrama Entidad-Relación (DER), lo que permitió organizar adecuadamente la información en tablas estructuradas y facilitar su manipulación. Se procuró que todas las tablas cumplieran con la tercera forma normal; sin embargo, en algunos casos no fue posible aplicarla completamente, ya que dificultaba la operatividad y el manejo de los datos.

A partir de nuestros resultados, no observamos variaciones significativas en la cantidad total de habitantes entre el Censo 2010 y el Censo 2022, ni cambios relevantes en la cantidad de defunciones por categoría en función del tiempo.

El análisis comparativo por jurisdicción permitió identificar que la provincia de Buenos Aires presentó la mayor cantidad de registros en la mayoría de los análisis realizados, tanto en los datos censales como en las tablas de 'Cobertura de salud' y en 'los establecimientos de salud', entre otros. Lo cual refleja su peso demográfico dentro del país. No obstante, en el análisis de la tasa de mortalidad por provincia, en el año 2022, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó valores considerablemente superiores en comparación con el resto de

las jurisdicciones.

En síntesis, el trabajo permitió integrar y analizar información de distintos períodos, evidenciando la importancia de contar con bases de datos correctamente estructuradas para la adecuada interpretación y visualización de los datos.

Referencias

[1] Sergio Terrasa, Fernando Rubinstein, Nancy Giraudo, and Marcelo Bortman. Mortalidad infantil y prematura en argentina: poder explicativo de las diferencias socioeconómicas y de acceso a servicios de salud. 07 2015.

[2] Mariana BELLO and Victor M BECERRIL-MONTEKIO. Sistema de salud de Argentina). *Salud pública Méx*, pages 137 – 161, 01 2011.

[3] Indec: Instituto nacional de estadística y censos de la república argentina.

[4] Registro federal de establecimientos de salud (refes).

[5] Defunciones ocurridas y registradas en la república argentina.

7. Apéndice

7.1. Clasificación CIE-10

Capítulo	Códigos	Descripción
I	A00–B99	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
II	C00–D48	Neoplasias
III	D50–D89	Enf. de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
IV	E00–E90	Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas
V	F00–F99	Trastornos mentales y del comportamiento
VI	G00–G99	Enfermedades del sistema nervioso
VII	H00–H59	Enfermedades del ojo y sus anexos
VIII	H60–H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
IX	I00–I99	Enfermedades del sistema circulatorio
X	J00–J99	Enfermedades del sistema respiratorio
XI	K00–K93	Enfermedades del sistema digestivo
XII	L00–L99	Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
XIII	M00–M99	Enf. del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
XIV	N00–N99	Enfermedades del sistema genitourinario
XV	O00–O99	Embarazo, parto y puerperio
XVI	P00–P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
XVII	Q00–Q99	Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas
XVIII	R00–R99	Hallazgos anormales no clasificados en otra parte
XIX	S00–T98	Traumatismos y consecuencias de causas externas
XX	V01–Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad
XXI	Z00–Z99	Factores que influyen en el contacto con serv. de salud
XXII	U00–U99	Códigos para situaciones especiales

Cuadro 6: Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por Capítulos.

7.2. Cantidad de Habitantes por provincia

La Figura 8 muestra la cantidad de habitante por provincia para los años 2010 y 2022. Los distritos más poblados son Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe y Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

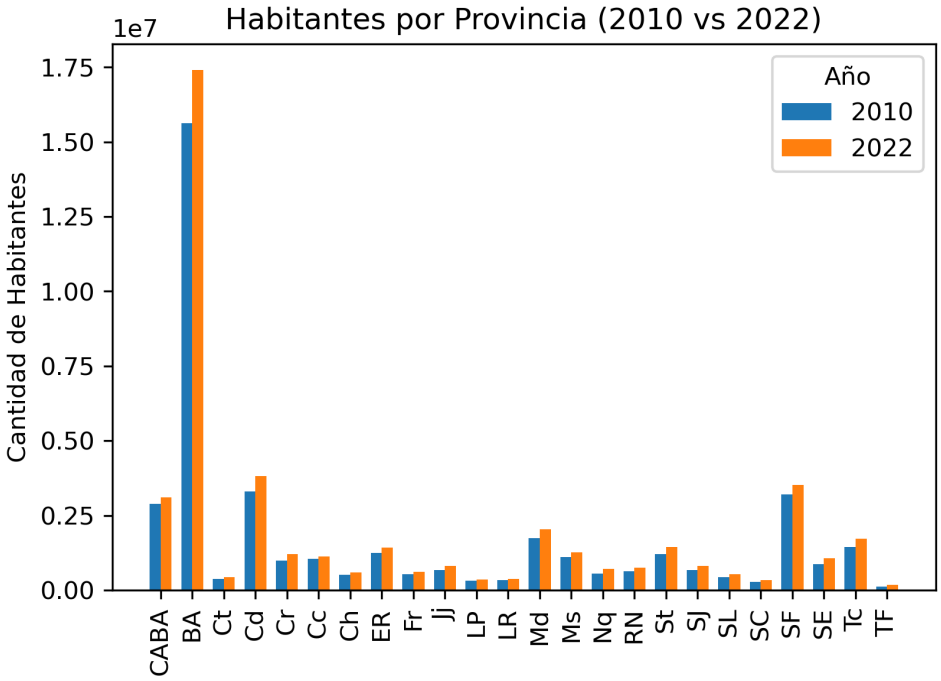


Figura 8: Cantidad de habitantes por provincia para los años 2010 y 2022.